현미경적 혈뇨, 위험도에 맞춰 안전하게

눈에 보이지 않는 미세한 혈뇨 (Microscopic Hematuria) — 대부분 양성, 그러나 위험도에 따라 정확한 평가가 필요합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

대부분은 암이 아니지만 확인은 필요합니다

원인과 위험도에 따라 필요한 검사만 고릅니다

95%

대부분은 양성

전체 환자의 95% 이상은 암이 아닌 원인으로 설명됩니다. 다만 드문 병을 놓치지 않도록 원인을 확인해야 합니다.

막연한 걱정보다 확인

3개

현미경 검사 기준

고배율 시야당 적혈구가 3개 이상이면 현미경적 혈뇨로 봅니다. 소변스틱 결과만으로는 확정하지 않습니다.

검사 결과 재확인

3단계

위험에 맞춘 평가

연령·흡연력·혈뇨 정도 등을 함께 살펴 저·중·고 위험으로 나눕니다. 그 결과에 따라 검사를 고릅니다.

필요한 검사 선택

소변스틱에 피가 나왔다는 표시만으로 확진하지 않습니다.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

눈에는 안 보여도 소변에서 피가 보입니다

현미경으로 적혈구를 직접 확인해야 합니다

3개 이상

확인 기준

현미경의 고배율 시야 하나에서 적혈구를 직접 셈

1회

현미경 검사

기준에 맞으면 평가 시작

2~31%

성인 보고 범위

연구별 보고 범위

스틱 검사는 출발점

잠혈 양성만으로 확진하지 않고 현미경 검사로 적혈구가 실제로 보이는지 확인합니다.

평가가 필요한 이유

생리나 운동 같은 일시적 원인부터 콩팥·요로 질환까지 가능하므로 함께 살핍니다. 소변검사 결과와 증상, 채취 상황을 함께 확인하고 일시적 원인이 해결된 뒤에도 피가 남는지 다시 봅니다.

눈에 보이지 않는 혈뇨라도 새로 생겼다면 현미경 검사 결과를 확인하세요. 일시적 원인이 해결된 뒤에도 남는지 살펴봅니다.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

정밀 검사 전에 일시적 원인을 살핍니다

소변 채취 상황과 증상을 함께 확인합니다

요로감염

배뇨할 때 따갑거나 자주 마렵다면 감염 여부를 살핍니다. 치료를 마친 뒤 소변에서 피가 사라졌는지 다시 봅니다.

생리와 격한 운동

생리혈이 섞이지 않게 채취하고, 격한 운동 뒤라면 최소 48시간 휴식한 뒤 재검합니다.

항응고제 복용

항응고제를 먹는 분도 혈뇨 평가 기준은 같습니다. 약 탓으로만 돌리지 말고 다른 원인이 있는지 확인합니다.



그림 · 혈뇨의 원인은 여러 곳에서 생길 수 있습니다.

원인이 해결된 뒤 혈뇨가 사라졌는지 다시 확인합니다.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료 가능한 원인도 많습니다

소변 증상과 검사 결과로 원인을 좁힙니다

요로감염

따가움·잦은 소변이 있으면 감염을 치료하고 소변검사를 다시 해 혈뇨가 남는지 봅니다.

요로결석

요로결석은 옆구리 통증이 함께 올 수 있습니다. 증상과 검사 결과를 보고 영상검사로 확인합니다.

전립선비대

남성에서 소변 줄기가 약하거나 배뇨가 늦어질 수 있습니다. 이런 증상이 혈뇨와 함께 있는지 알립니다.

콩팥 질환

단백뇨·고혈압·부종이 혈뇨와 함께 있으면 콩팥 평가가 필요합니다. 소변검사의 다른 항목도 살핍니다.

일시적 운동·생리 영향도 검사 전에 다시 확인합니다.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

콩팥 문제인지 요로 문제인지 살핍니다

동반 소견에 따라 진료 방향이 달라집니다

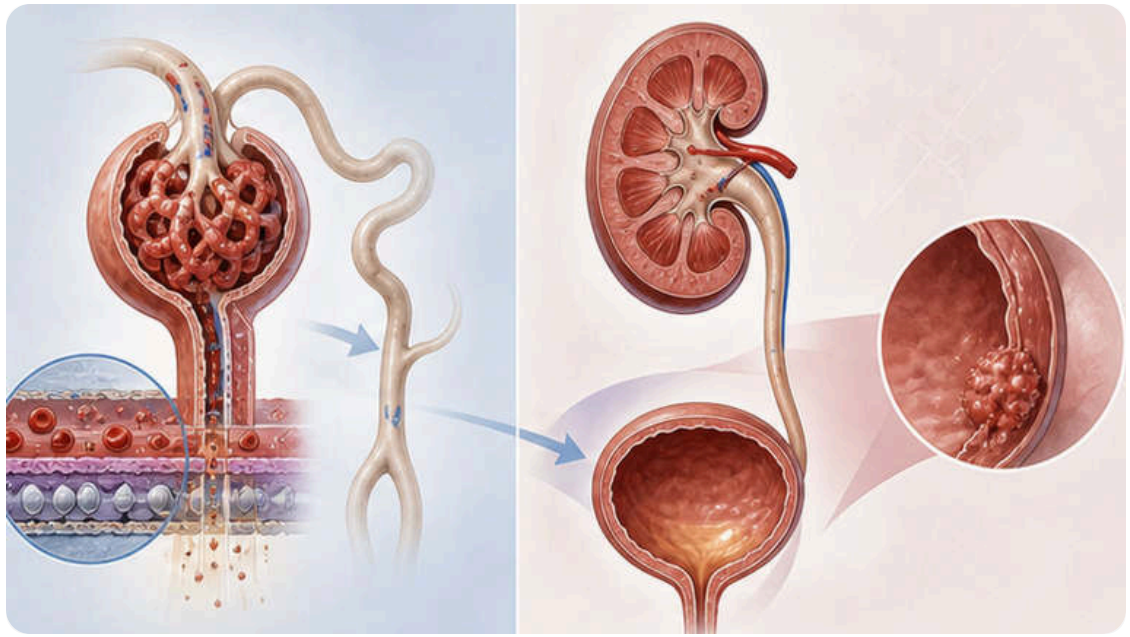


그림 · 소변검사의 다른 소견이 출처를 짐작하게 합니다.

콩팥을 의심할 단서

단백뇨, 고혈압, 부종, 모양이 변한 적혈구가 있으면 콩팥 평가를 고려합니다. 이런 단서는 진료 때 함께 알리세요.

요로를 의심할 단서

옆구리 통증이나 배뇨 증상이 있으면 감염·결석·요로 병변을 살핍니다. 소변을 보는 양상의 변화를 기록해 두세요.

콩팥 소견이 있어도 필요한 비뇨기 평가는 별도로 판단합니다.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

위험도는 여러 조건을 함께 살핍니다

2025년 지침에서는 여성의 나이만으로 고위험이 되지 않습니다

낮은 위험

여성 60세 미만, 남성 40세 미만 등 다른 위험요인이 적은 경우입니다. 혈뇨 정도와 흡연력도 함께 봅니다.

중간 위험

여성 60세 이상 또는 남성 40~59세는 나이 기준으로 중간 위험에 해당합니다. 흡연력과 혈뇨 정도 등 다른 위험인자도 함께 살핍니다.

높은 위험

남성 60세 이상, 심한 흡연력, 많은 적혈구, 눈에 보인 혈뇨 병력 등을 함께 봅니다. 위험이 높다면 더 자세한 검사를 상의합니다.



그림 · 나이 하나가 아니라 흡연력·검사 수치도 중요합니다.

위험도는 나이와 흡연력, 소변검사 결과를 함께 보아 정합니다.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

위험도에 따라 검사 강도가 달라집니다

불필요한 검사와 놓치는 위험을 함께 줄입니다

위험도	주로 하는 평가
낮은 위험	위험이 낮다면 6개월 안에 소변검사를 다시 해 혈뇨가 남아 있는지 확인합니다.
중간 위험	중간 위험이면 방광경과 콩팥 초음파를 권합니다. 방광경을 미루는 경우에는 대체 검사와 12개월 내 재평가를 상의합니다.
높은 위험	높은 위험이면 방광경과 요로를 보는 CT 검사를 권합니다. 조영제를 쓸 수 없다면 본인에게 맞는 대체 검사를 상의합니다.
콩팥 질환 의심	단백뇨·고혈압·부종처럼 콩팥 질환이 의심되면 콩팥 기능과 단백뇨를 확인하고 신장내과 진료를 고려합니다.

검사 선택은 개인의 위험요인과 신장 기능을 함께 보고 정합니다.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

소변스틱부터 맞춤 검사까지

검사 결과를 단계별로 확인합니다

1

잠혈 표시

소변스틱

소변스틱에 잠혈이 표시돼도 그것만으로 확진하지 않고 현미경 검사를 합니다.

2

현미경 확인

적혈구

현미경에서 고배율 시야당 적혈구가 3개 이상인지 확인합니다.

3

위험도 평가

저·중·고

연령·흡연력·혈뇨 정도와 눈에 보인 혈뇨 병력을 함께 봅니다.

4

맞춤 검사

재평가

위험에 맞춘 검사를 받고 새로운 증상이나 혈뇨 양의 변화는 곧 알립니다.

눈에 보이는 혈뇨, 혈뇨 양의 급증 또는 새 위험인자가 생기면 재평가 날짜를 기다리지 마세요.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이런 변화가 생기면 다시 진료받으세요

정해 둔 재검 날짜보다 증상 변화가 우선입니다

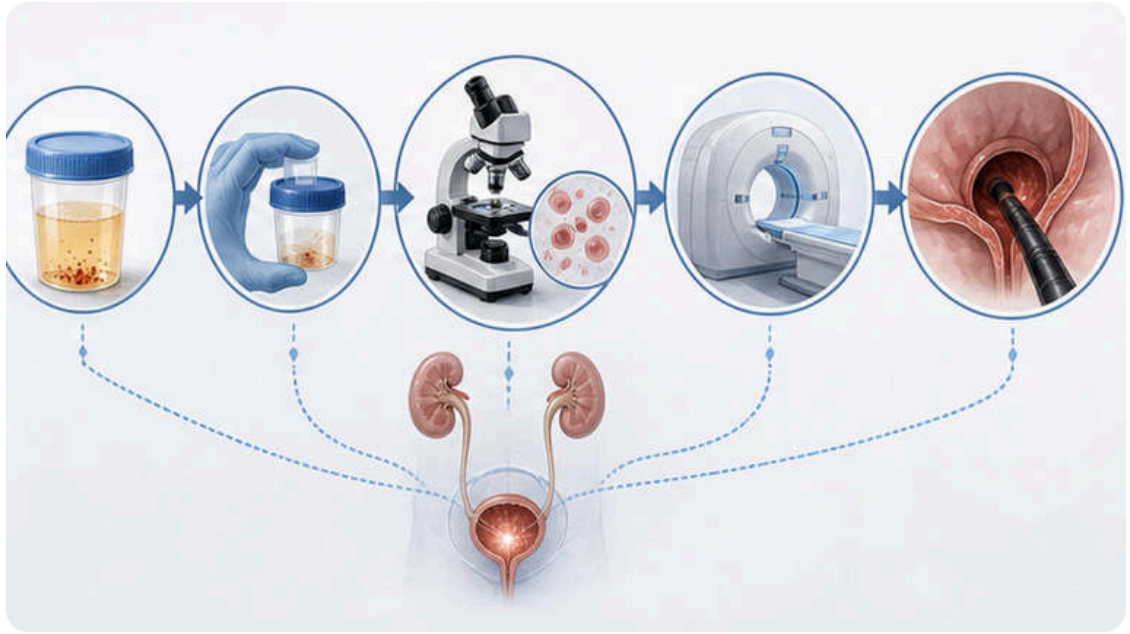


그림 · 증상이 달라지면 재평가 계획도 달라집니다.

눈에 보이는 혈뇨

소변이 붉거나 콜라색으로 보이면 한 번이라도 알립니다. 새로운 눈에 보이는 혈뇨는 재평가가 필요한 변화입니다.

새 배뇨 증상

옆구리 통증, 심한 빈뇨, 소변 볼 때의 통증이나 잔뇨감이 새로 생기면 확인합니다.

콩팥 신호

거품뇨, 혈압 상승, 다리 부종이 함께 나타나면 콩팥 질환을 살피기 위해 진료받습니다.

새로 보이는 혈뇨, 혈뇨 양 급증 또는 새로운 배뇨 증상이 생기면 재검 날짜를 기다리지 말고 빠르게 내원하세요.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈뇨 결과를 안전하게 따라가는 법

검사 결과를 보관하고 정해진 재검을 받으세요

01 소변스틱 양성 뒤 현미경으로 적혈구를 다시 확인합니다

02 감염·생리·격한 운동 같은 일시적 원인을 살피고 필요하면 다시 검사합니다

03 항응고제를 먹어도 혈뇨를 약 탓으로만 돌리지 않고 같은 기준으로 평가합니다

04 위험도는 나이와 흡연력, 현미경에서 보인 혈뇨 정도를 함께 보고 정합니다

05 낮은 위험이면 6개월 안에 소변검사를 다시 해 혈뇨가 남는지 확인합니다

06 중간·높은 위험이면 담당 의사와 방광경·영상검사 계획을 세웁니다

07 단백뇨·고혈압·다리 부종이 함께 있으면 콩팥 평가가 필요합니다

08 눈에 보이는 혈뇨가 새로 생기거나 양이 크게 늘면 재검일을 기다리지 말고 알립니다

혈뇨를 한 번 확인한 뒤에도 계획한 추적검사를 지키는 것이 중요합니다. 새로운 증상이나 혈뇨 양의 변화가 생기면 재검 날짜보다 먼저 알리세요.

근거 · AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

혈뇨와 전신 염증이 함께 있으면 알려 주세요

기존 콩팥·비뇨기 평가와 함께 전신 혈관염의 단서도 살핍니다

소변 외의 변화

혈뇨나 단백뇨와 함께 열이 나거나 염증 수치가 높으면 전신 염증 질환의 가능성도 살핍니다.

상황에 맞춘 검사

전신 혈관염은 여러 장기를 침범할 수 있습니다. 의료진은 증상과 다른 검사 결과를 함께 보고 ANCA 검사가 필요한지 정합니다.

항체 하나로 확진하지 않기

ANCA가 양성이라고 곧바로 혈관염인 것은 아니며, 음성인 혈관염도 있습니다. 임상 상황과 함께 해석합니다.

소변 증상과 함께 새로 생긴 발열 등 전신 증상을 진료 때 알려 주세요.

아산 28회 연수강좌 — 자가항체 검사 해석의 핵심 포인트(홍석찬)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

현미경적 혈뇨가 나온 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 개별 검사는 진료에서 정합니다.

참고한 자료

AUA/SUFU 2025 현미경적 혈뇨 지침 · 대한신장학회 2023

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요